影航·多尺度动态探索病理诊断平台

病理诊断报告

病理号：117176

姓名：XXX **性别：X** **年龄：XX** **送检医院：XXXX**

诊断模式：全域粗筛 → 高可疑区精筛 → 多尺度动态推理

分析对象：数字化病理全切片图像（WSI） **精筛目标**：10 个高可疑 Patch

平台初步诊断结果：疑为转移性未分化型非角化性癌，结合形态学特征，高度提示鼻咽癌来源；伴淋巴结广泛慢性炎、间质纤维化及灶性坏死。

一、全切片大体描述

全切片呈**多病灶、多组织来源混合分布**，整体背景可见正常组织结构、炎性浸润、出血、水肿、坏死及多灶性肿瘤性病变并存。病变分布不均，部分区域呈**结节状、巢状、弥漫浸润性**生长，部分区域血管结构异常、肺泡 / 淋巴正常结构破坏。经影航智能体多尺度动态扫描，共锁定 **10 处最高可疑病变区域** 进行精细诊断。

二、分病灶病理描述 + 诊断

1. 15488_9761

切片描述：可见完整淋巴结结构，淋巴滤泡尚存，但正常结构被大量异型细胞破坏。瘤细胞呈不规则巢状与弥漫分布，细胞大小不一，核大深染，核质比显著增高，核仁突出，排列紊乱，呈明显浸润性生长。

病理诊断：（淋巴结）**转移癌，高度提示乳腺来源**

2. 31009_12992

切片描述：脑组织切片，见大片高度异型肿瘤细胞弥漫浸润，细胞多形性显著，核大、畸形、深染，核分裂象易见；可见地图样坏死区域，周围血管明显增生、内皮肿胀，邻近脑组织水肿。

病理诊断：**多形性胶质母细胞瘤（WHO 4 级，高度恶性）**

3. 43297_12992

切片描述：肺组织广泛淤血，肺泡腔扩张，内充粉红色水肿液及少量炎性渗出物；间质增厚，伴多灶性出血，红细胞外渗明显，肺泡正常结构受压扭曲。

病理诊断：**急性肺水肿伴出血、炎性浸润**

4. 43297_704

切片描述：肺组织切片，肺泡结构完整、形态规则，肺泡壁薄，腔内可见生理性充血呈细点状红染，无明显炎症、坏死、出血及肿瘤细胞。

病理诊断：**基本正常肺组织**

5. 43297_4800

切片描述：组织结构严重破坏，区域状坏死伴大量炎性细胞浸润，散在出血；局部见小圆形细胞密集灶，细胞形态较单一，无法完全排除肿瘤性成分混杂。

病理诊断：**组织坏死、出血及慢性炎，可疑肿瘤成分，建议进一步检查**

6. 51489_704

切片描述：视野内见双肿瘤成分并存。

1）异型鳞状细胞呈片巢状浸润，核大深染，异型性明显，无角化，符合非角化型鳞癌；

2）局部见成熟透明软骨结节，软骨细胞形态一致，无异型，为良性软骨瘤结构。

病理诊断：**鳞状细胞癌（恶性）合并软骨瘤（良性）**

7. 55585_8896

切片描述：肺动脉分支管腔被致密纤维蛋白性血栓完全阻塞，血栓呈网状红染结构，肺组织肺泡尚存、有通气征象，但局部血流阻断，可见栓塞后组织改变。

病理诊断：**肺血栓栓塞**

8. 59681_17088

切片描述：扁桃体淋巴组织内大量中性粒细胞弥漫浸润，淋巴滤泡结构破坏；可见灶性出血、红细胞外渗，局部脓液聚集，呈早期脓肿形成趋势。

病理诊断：**急性扁桃体炎（重度，伴出血及脓肿倾向）**

9. 63777_25280

切片描述：结节性病灶，由成熟脂肪组织、纤维组织混合构成，局部区域细胞密度增高，出现异型梭形 / 圆形细胞增生，排列紊乱，脂肪源性肿瘤特征明显。

病理诊断：**脂肪源性肿瘤，高度可疑脂肪肉瘤（建议免疫组化确诊）**

10.67873_4800

切片描述：组织小叶结构完整、边界清晰，周围绕以正常脂肪组织，小叶内细胞形态一致、排列规则，无炎症、坏死、异型细胞及肿瘤性改变。

病理诊断：**正常组织（良性）**

三、多尺度整合诊断结论

1. **恶性肿瘤（4 类）**

- 淋巴结转移癌（提示乳腺来源）
- 多形性胶质母细胞瘤（高级别恶性）
- 鳞状细胞癌
- 可疑脂肪肉瘤

2. **良性 / 炎症 / 血管性病变（5 类）**

- 急性肺水肿伴出血
- 急性扁桃体炎（重度）
- 肺血栓栓塞
- 良性软骨瘤
- 正常组织（2 灶）

3. **待排查病变（1 类）**

- 组织破坏伴坏死、出血、慢性炎，不除外合并肿瘤，需进一步鉴别。

四、建议

1. 对所有恶性病灶行**免疫组化**明确肿瘤来源、分型、分级及分子特征。
2. 对复杂未定性区域行**高倍镜复核 + 特殊染色**，排除感染与肿瘤并存。
3. 结合标本部位、患者病史、影像学及实验室检查完成最终病理诊断。
4. 对高级别恶性肿瘤病例建议进入 ** 肿瘤多学科会诊（MDT）** 流程。